

Trabajo Práctico Nº 24: Demencia Fronto- Temporal VC

Grupo:

- Estefanía Ribeiro
- Juana Saiz Miramon
- Franco Mendez Casariego

1. Complete el siguiente cuadro

	Enfermedad de Alzheimer	DFT variante conductual
Atrofia	Lóbulos temporales mediales → Principalmente hipocampo y corteza entorrinal Lóbulos parietales	Corteza Orbitofrontal Corteza cingular ventromedial Corteza dorsolateral
Anatomía Patológica	Presencia de placas seniles de β -amiloide extracelulares y ovillos neurofibrilares intracelulares con proteína tauhiperfosforilada. Angiopatía amiloidea Pérdida neuronal Gliosis	Degeneración lobar frontotemporal → 3 variantes histológicas: • Tau positiva (tipo Pick) con cuerpos y células de Pick • TDP-43 positiva • FUS positiva o sin marcador específico
Funciones Cognitivas principalmente afectadas	Etapa temprana: • Memoria episódica reciente • Aprendizaje • Orientación Etapa avanzada: • Lenguaje • Funciones visuoespaciales • Funciones ejecutivas	Funciones ejecutivas y sociales: • Control inhibitorio • Toma de decisiones • Planificación • Flexibilidad cognitiva • Empatía Etapa avanzada: • Memoria • Orientación
Características principales	Deterioro progresivo de la memoria, lenguaje y orientación Fase inicial: paciente puede presentar anosognosia, ansiedad o depresión leve Fase moderada y severa: Alucinaciones, paranoia, irritabilidad, pérdida de autonomía funcional	Cambios marcados de la personalidad y conducta social → Desinhibición, apatía, conductas repetitivas o compulsivas, pérdida de insight y rigidez mental

2. Mencione los criterios de exclusión para el diagnóstico de DFTVc.

- Síntomas que puedan explicarse mejor por trastornos no degenerativos (por ejemplo enfermedad cerebrovascular, secuelas cerebelosas, efectos de sustancias).
- Déficits cognitivos que puedan explicarse mejor por un cuadro psiquiátrico (por ejemplo depresión mayor, trastorno bipolar, esquizofrenia).
- Ausencia de progresión clínica y hallazgos que sugieran una condición no neurodegenerativa (evaluación neuropsicológica relativamente normal, imágenes cerebrales normales, mantenimiento de las actividades de la vida diaria), casuística atribuible a fenocopias.

3. ¿Cuáles son las características neuropsiquiátricas de la DFT-vc variante apática y variante desinhibida?

Variante apática

- Apatía temprana e inercia: disminución marcada de la iniciativa y motivación, pérdida de interés en actividades previamente relevantes.
- Pérdida de empatía y conducta social retraída: menor preocupación por los demás y por el entorno social.
- Déficits ejecutivos en comportamiento y planificación, con relativa preservación temprana de memoria episódica y habilidades visuoespaciales.

Variante desinhibida

- Desinhibición social temprana: conducta social inapropiada, pérdida de modales y decoro, actos impulsivos o temerarios.
- Cambios en la dieta y la conducta alimentaria: hiperoralidad, compulsión por comer y preferencia por alimentos dulces; posible aumento del consumo de alcohol o tabaco.
- Conductas repetitivas, estereotipadas o compulsivas; pérdida del cuidado personal e higiene; episodios de euforia y toma de decisiones riesgosas que afectan la vida diaria.

4. ¿Qué son las fenocopias?

Fenocopias son pacientes que cumplen criterios clínicos de DFT-vc pero presentan escasa o nula progresión, mejor rendimiento neuropsicológico, imágenes cerebrales normales y relativa preservación de las actividades de la vida diaria, sugiriendo ausencia de un proceso neurodegenerativo subyacente.

Etiologías alternativas asociadas a fenocopias incluyen presentaciones atípicas de trastornos psiquiátricos: trastorno bipolar de comienzo tardío, trastornos de la personalidad, depresión atípica, TDAH crónico y abuso de sustancias.